ASST Colline Orobiche - Presidio Ospedaliero San Narno
Dipartimento dei Servizi Diagnostici
UOC Radiologia Diagnostica e Interventistica
Direttore: Prof. Gianluigi Personeni
Sezione di Neuroradiologia: Dott. Carlo Bonacina

Viale delle Rimembranze 38
24068 Seriate (BG)
Segreteria TC: 035 3061744
Fax 035 3061790
radiologia.sannarno@asst-co.example.it

REFERTO DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA

TC encefalo e TC collo-torace-addome-pelvi con mezzo di contrasto - rivalutazione oncologica in corso di terapia a bersaglio molecolare

ASSISTITO

Cognome e nome:	**EL AMRANI YOUSSEF**
Nato il / a:	**14/09/1962 - Casablanca (Marocco)**
Cittadinanza:	**marocchina**
Residenza:	**Via Guglielmo Marconi 54/B, 24044 Dalmine**
Telefono:	**+39 349 7710562**
Esenzione:	**048**

Acc. TC encefalo:	RX26-0412233
Acc. TC collo-TAP:	RX26-0412234
Prenotazione CUP:	CUP-BG-26-3378145
NRE:	0300A4718265093
Data esame:	22/09/2026 ore 14:20
Data referto:	23/09/2026
Richiedente:	Dott. Fabio Mazzoleni - UOC Oncologia Medica

Codice fiscale L M R Y S F 6 2 P 1 4 Z 3 3 0 B

TC encefalo: RX26-0412233

TC collo-torace-addome-pelvi: RX26-0412234

QUESITO DIAGNOSTICO E NOTIZIE CLINICHE

Quesito: rivalutazione di malattia dopo 6 mesi di terapia in paziente con adenocarcinoma polmonare del lobo superiore destro, stadio IVB (delezione dell'esone 19 di EGFR, PD-L1 TPS 5%), in trattamento con osimertinib 80 mg/die dal marzo 2026. Nota metastasi cerebrale cerebellare sinistra trattata con radiochirurgia stereotassica il 02/04/2026.

Il sig. El Amrani, ex operaio edile presso la Edilcostruzioni Brembate S.r.l. fino al 2024, è ex fumatore (40 pack-years, cessazione nel 2025). Comorbidità: diabete mellito tipo 2 in terapia con metformina 1000 mg x 2 (sospesa 48 ore prima dell'esame, come da protocollo), epatite B pregressa (HBsAg negativo, anti-HBc positivo) in profilassi con entecavir 0,5 mg. Creatinina del 18/09/2026 1,08 mg/dL, eGFR (CKD-EPI) 74 mL/min/1,73 m². Il paziente riferisce digiuno rituale islamico nei giorni precedenti, sospeso su indicazione dell'oncologo: idratazione orale adeguata confermata all'accettazione.

> *ATTENZIONE - Reazione allergica a mezzo di contrasto iodato (orticaria diffusa ed edema palpebrale dopo iopromide, TC del 11/01/2026 presso Ospedale Civile di Treviglio Sud). Esame eseguito previa premedicazione e con cambio di molecola, previo consenso informato e in presenza del medico anestesista Dott.ssa Paola Carminati.*

PREMEDICAZIONE E MEZZO DI CONTRASTO

Ora / data	Farmaco o prodotto	Via	Somministrato da
01:20 del 22.09.26	prednisone 50 mg	os	a domicilio (autosomministrazione)
07:20 del 22.09.26	prednisone 50 mg	os	a domicilio, verificato dalla figlia Samira El Amrani
13:25	prednisone 50 mg + cetirizina 10 mg	os	inf. Ivana Gritti
14:18	iomeprolo 350 mgI/mL, 95 mL flusso 3,5 mL/s, ago-cannula 18G antecubitale sx	ev	TSRM Davide Cortinovis (iniettore automatico)
14:40	osservazione post-contrasto: nessuna reazione avversa	-	inf. I. Gritti

TECNICA

TC multistrato a 128 file di detettori. **Encefalo:** acquisizione assiale prima e dopo mezzo di contrasto, ricostruzioni 1 mm in finestra parenchimale e ossea. **Collo-torace-addome-pelvi:** acquisizione in fase tardo-arteriosa (torace) e portale (collo-addome-pelvi), ricostruzioni multiplanari 1,25 mm. Tecnica di acquisizione supervisionata dal medico specializzando dott. Nicolò Pesenti; post-elaborazione volumetrica a cura della TSRM Elisa Rota.

Confronto: TC collo-torace-addome-pelvi del 17 giugno 2026 (acc. RX26-0218877) e TC basale del 04/03/2026 (acc. RX26-0097412), entrambe eseguite presso questa UOC; RM encefalo del 15-07-2026 eseguita presso Centro Diagnostico Valle Seriana, disponibile su PACS regionale.

Documento con dati relativi alla salute (art. 9 Reg. UE 2016/679): vietata la diffusione. Copia conforme all'originale informatico.

REPERTI

TC encefalo (referto a cura della Sezione di Neuroradiologia)

Esiti di trattamento radiochirurgico in sede emisferica cerebellare sinistra: lesione residua con enhancement periferico sottile di 6 x 5 mm (precedente 9 x 8 mm), con modesto edema perilesionale in riduzione. Non nuove lesioni focali sovra- o sottotentoriali apprezzabili con la presente metodica. Sistema ventricolare in asse, di normali dimensioni. Non segni di ipertensione endocranica. Non alterazioni ossee della teca.

Collo

Non adenopatie laterocervicali o sovraclaveari di significato patologico. Nodulo tiroideo ipodenso del lobo destro di 11,4 mm, invariato, già valutato ecograficamente (TIR2).

Torace

Lesione primitiva al segmento apicale del lobo superiore destro: formazione solida spiculata in riduzione dimensionale, attualmente di 21,4 x 16,2 mm (precedente 27,3 x 19,1 mm; basale 38,2 x 29,0 mm), con incipiente cavitazione centrale. Micronoduli satelliti in riduzione. Linfonodo ilare destro di 12,5 mm in asse corto (precedente 14,2 mm); linfonodo paratracheale inferiore destro (stazione 4R) di 9,3 mm. Comparsa di tenue area a vetro smerigliato subpleurica al lobo inferiore sinistro, aspecifica: in considerazione della terapia in atto da valutare clinicamente il possibile significato di polmonite da farmaco. Non versamento pleurico né pericardico. Enfisema centrolobulare apicale bilaterale.

Addome e pelvi

Fegato di normali dimensioni. In corrispondenza del VI segmento secondo Couinaud si conferma lesione ipodensa di 8 mm (densità 12 unità Hounsfield), invariata e compatibile con cisti. **Comparsa di nuova lesione ipodensa a margini sfumati al segmento VII**, di 14,6 mm, con lieve enhancement periferico in fase portale, sospetta per localizzazione secondaria. Surrene sinistro: nodulo di 17,2 mm, in lieve riduzione (precedente 19,4 mm). Colecisti alitiasica. Pancreas, milza e reni nei limiti. Non adenopatie addominali o pelviche. Prostata aumentata di volume. Scheletro: lesione osteoaddensante del soma di L2, invariata, di verosimile natura secondaria trattata.

Valutazione secondo RECIST 1.1 (lesioni target misurate dal dott. N. Pesenti, verificate dalla Dott.ssa M. Locatelli)

Lesione target	Basale 04/03/2026	Precedente 17/06/2026	Attuale	Variazione
T1 - LSD, primitiva (asse lungo)	38,2 mm	27,3 mm	21,4 mm	-
T2 - linfonodo ilare dx (asse corto)	18,1 mm	14,2 mm	12,5 mm	-
T3 - surrene sx	26,3 mm	19,4 mm	17,2 mm	-
Somma dei diametri	82,6 mm	60,9 mm	51,1 mm	-38% vs basale
Lesioni non target	metastasi L2	invariata	invariata	-
Nuove lesioni	-	-	fegato, segm. VII	**presente**

CONCLUSIONI

Risposta dissociata: riduzione delle lesioni target (somma dei diametri -38% rispetto al basale), ma comparsa di nuova lesione epatica sospetta al segmento VII. Secondo RECIST 1.1 il quadro è formalmente classificabile come progressione di malattia (nuova lesione). Lesione cerebellare trattata in ulteriore riduzione. Si suggerisce discussione al gruppo oncologico multidisciplinare toracico ed eventuale caratterizzazione della lesione epatica con RM con mezzo di contrasto epatospecifico o biopsia ecoguidata.

Esito anticipato telefonicamente al Dott. Mazzoleni il 23/09/2026 alle ore 11:05. Il paziente, assistito dalla figlia Samira in qualità di interprete, è stato informato che il referto sarà discusso alla prossima visita oncologica del 30 settembre 2026.

Il Medico Radiologo refertante
Dott.ssa Marta Locatelli
Specializzando: dott. Nicolò Pesenti
TC encefalo: Dott. Carlo Bonacina (OMCeO BG n. 6214), 23.09.2026

P.O. SAN NARNO - RADIOLOGIA
Dott.ssa M. LOCATELLI
OMCeO BG n. 7329

Seriate, 23/09/2026

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Documento con dati relativi alla salute (art. 9 Reg. UE 2016/679): vietata la diffusione. Copia conforme all'originale informatico.

INFORMAZIONI DOSIMETRICHE (D.LGS. 101/2020, ART. 161)

Serie	kV	CTDIvol (mGy)	DLP (mGy·cm)	Dose efficace stimata
Encefalo senza mdc	120	48,6	812	1,7 mSv
Encefalo con mdc	120	47,9	798	1,6 mSv
Torace fase tardo-arteriosa	100	6,3	241	3,4 mSv
Collo-addome-pelvi fase portale	100	8,1	563	8,4 mSv
Totale esame	-	-	2414	15,1 mSv

Dose efficace stimata con coefficienti di conversione ICRP 103 per distretto. Dose cumulativa da TC registrata nell'anno solare per l'assistito Y. El Amrani: DLP complessivo 7350 mGy·cm (4 esami). Classe di dose secondo D.Lgs. 101/2020: III. Fisico medico di riferimento: dott. Andrea Brembilla.

ALLEGATO - SCHEDA DI SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO IN PAZIENTE A RISCHIO

Assistito:	Youssef El Amrani	Data di nascita:	14.09.1962
Tessera sanitaria:	80380010508209424620	Peso:	78 kg
PA pre-esame:	138/84 mmHg	Cartella ambulatoriale:	AMB-ONC-2026-01472

Valutazione pre-procedurale

- ☒ Pregressa reazione a mdc iodato documentata
- ☐ Asma bronchiale o atopia
- ☐ Insufficienza renale (eGFR < 30)
- ☒ Metformina sospesa
- ☒ Premedicazione completata secondo protocollo aziendale
- ☒ Presenza dell'anestesista in sala
- ☐ Ipertiroidismo non controllato
- ☒ Consenso informato firmato

Il sottoscritto Youssef El Amrani, informato sui rischi connessi alla somministrazione di mezzo di contrasto iodato in presenza di pregressa reazione allergica e sulle alternative diagnostiche, acconsente all'esecuzione dell'esame. Il consenso è stato illustrato in lingua araba con la mediazione della figlia, sig.ra Samira El Amrani, tel. 333 9182407, e alla presenza del mediatore culturale aziendale sig. Rachid Ouali. La moglie, sig.ra Fatima Benali, ha chiesto di non ricevere informazioni cliniche dirette.

Firma dell'assistito

El Amrani Youssef
Per la traduzione: Samira El Amrani

Seriate, 22/09/2026

Il Medico che acquisisce il consenso

Dott.ssa Paola Carminati
UO Anestesia e Rianimazione, reperibile int. 4471

ASST COLLINE OROBICHE
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Dott.ssa P. Carminati
Matr. BG-08833

Consenso acquisito alle ore 13:30

Copia del referto trasmessa a: Dott. Fabio Mazzoleni (Ambulatorio di Oncologia Toracica) e al medico di medicina generale Dott.ssa Laura Ghisleni, Piazza Vittorio Veneto 3, Dalmine. Immagini disponibili su CD consegnato al sig. El Amrani il 25/09/2026.

Ritiro online - Y. El Amrani: https://referti.asst-co.example.it/q/REF-RAD-2026-118604

(1) Misurazioni RECIST 1.1 eseguite in finestra polmonare per T1 e in finestra mediastinica per T2-T3; linfonodi misurati in asse corto.
(2) Le unità Hounsfield riportate si riferiscono alla fase portale. Lesioni epatiche localizzate secondo la segmentazione di Couinaud.
(3) Referto preliminare inviato via fax all'Ambulatorio di Oncologia Toracica il 23.09.2026 dal TSRM D. Cortinovis.